4. Профессиональная квалификация: поддержание и износ

Что стало с теми, кто решает. Лекция мерила работу. Что стало с человеком внутри неё, не сказал ни один замер — кроме одного, и он спорный.

2 разбора · 2 классических режима с числами

Пример 1: доля упала без помощника — единственный замер износа на реальной работе. **Пример 2: отечественный помощник ArtInCol на той же процедуре** — та же величина, испытание сильнее, расход не мерен.

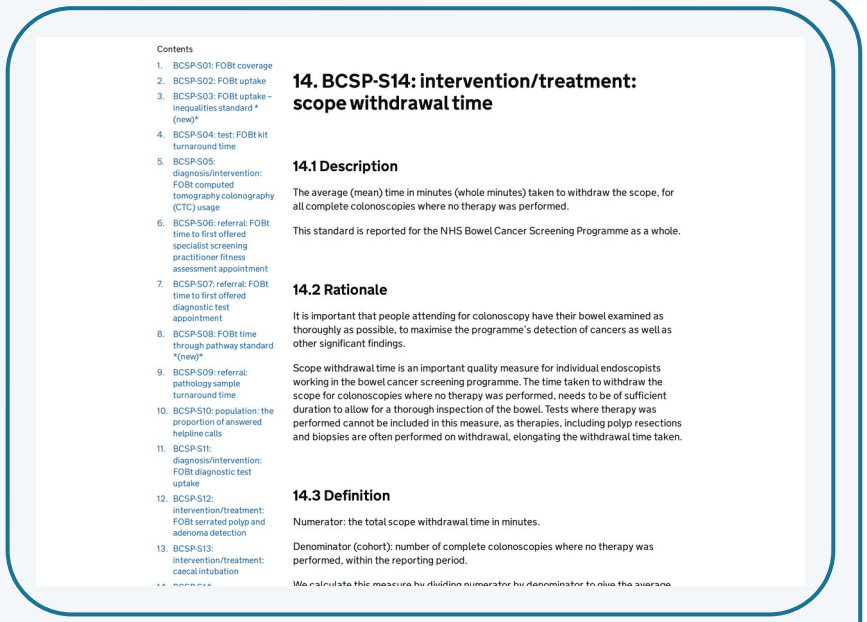


Квалификация: что замеряют и чем

Здесь измеряют самого исполнителя: в форме ли он. Навык расходуется молча.

Аденома — предраковое утолщение слизистой: снятая сегодня, она не станет раком через годы.

Данные о враче берут четырьмя способами, все — с обычного потока работы: процедур за год · доля процедур с находкой аденомы · время осмотра по таймеру · разбор случая.



Contents

1. BCSP-S01: FOBt coverage
2. BCSP-S02: FOBt uptake
3. BCSP-S03: FOBt uptake – inequalities standard * (new)*
4. BCSP-S04: test: FOBt kit turnaround time
5. BCSP-S05: diagnosis/intervention: FOBt computed tomography colonography (CTC) usage
6. BCSP-S06: referral: FOBt time to first offered specialist screening practitioner fitness assessment appointment
7. BCSP-S07: referral: FOBt time to first offered diagnostic test appointment
8. BCSP-S08: FOBt time through pathway standard *(new)*
9. BCSP-S09: referral: pathology sample turnaround time
10. BCSP-S10: population: the proportion of answered helpline calls
11. BCSP-S11: diagnosis/intervention: FOBt diagnostic test uptake
12. BCSP-S12: intervention/treatment: FOBt serrated polyp and adenoma detection
13. BCSP-S13: intervention/treatment: caecal intubation

14. BCSP-S14: intervention/treatment: scope withdrawal time

14.1 Description

The average (mean) time in minutes (whole minutes) taken to withdraw the scope, for all complete colonoscopies where no therapy was performed.

This standard is reported for the NHS Bowel Cancer Screening Programme as a whole.

14.2 Rationale

It is important that people attending for colonoscopy have their bowel examined as thoroughly as possible, to maximise the programme's detection of cancers as well as other significant findings.

Scope withdrawal time is an important quality measure for individual endoscopists working in the bowel cancer screening programme. The time taken to withdraw the scope for colonoscopies where no therapy was performed, needs to be of sufficient duration to allow for a thorough inspection of the bowel. Tests where therapy was performed cannot be included in this measure, as therapies, including polyp resections and biopsies are often performed on withdrawal, elongating the withdrawal time taken.

14.3 Definition

Numerator: the total scope withdrawal time in minutes.

Denominator (cohort): number of complete colonoscopies where no therapy was performed, within the reporting period.

We calculate this measure by dividing numerator by denominator to give the average

Долю находок не поднять старанием: аденома попадает в знаменатель и тогда, когда врач за складку не заглянул. Время осмотра — дисциплина, держать проще.

Решение: допускать, сузить допуск, приостановить, не продлить.

У кого в работе есть внешняя числовая проверка собственной формы — и кто её считает?

На снимке — стандарт BCSP-S14 «Scope withdrawal time» национальной программы скрининга рака кишечника, GOV.UK · показатели качества колоноскопии, Gastrointestinal Endoscopy 2015

Чем держат форму и куда встала модель

Три опоры держат форму, и ни одна не спрашивает человека: объём практики за год, допуск от организации, периодическое подтверждение.

У нас: периодическая аккредитация раз в пять лет — 144 часа учёбы плюс портфолио. **Считают часы и документы, результат работы — нет.**

Врач вернулся после года без процедур. Отзывать допуск было не за что. Первая процедура идёт иначе: прибор медленнее, рука дольше ищет угол, складку он проходит мимо. Осложнений нет, протокол написан, **и он этого не знает.**

Модель заняла одно действие из восьми — осмотр при выведении. **Добавилось одно: доверять ли рамке.**

Рекомендации профессионального общества, Gastrointestinal Endoscopy 2015 · Приказ Минздрава России от 28.10.2022 № 709н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»

Осмотр при выведении прибора: цена промаха и два порядка работы без модели

ПРОПУСТИТЬ АДЕНОМУ

останется в человеке до следующего обследования

УВИДЕТЬ ЛИШНЕЕ

снятие, кровотечение, повторный визит

ДИСЦИПЛИНА ВРЕМЕНИ

271 → 366 процедуры из тысячи

1 027 пациентов, жребием

ВТОРОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ

393 → 457 процедуры из тысячи

1 676 пациентов

Обычный порядок	ввести прибор	осматривать при выведении	заглянуть за складку
Два места вмешательства	таймер: не шесть минут, а девять	на экран смотрит и медсестра	

Где вмешиваются без модели

Плохой осмотр выглядит как хороший, в котором ничего не нашли — своего сигнала у врача нет.

Оба дают прирост того же порядка, что помощник, или больше, и ни один не бесплатен: первый стоит трёх минут врача на процедуру, второй — второго человека.

Zhao и соавт., Clinical Gastroenterology and Hepatology 2022 · *Lei и соавт., International Journal of Colorectal Disease 2024*

Пример 1: доля упала без помощника

БЫЛО ДО ПОМОЩНИКА

284 процедуры с находкой из тысячи

226 на 795

СТАЛО ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА

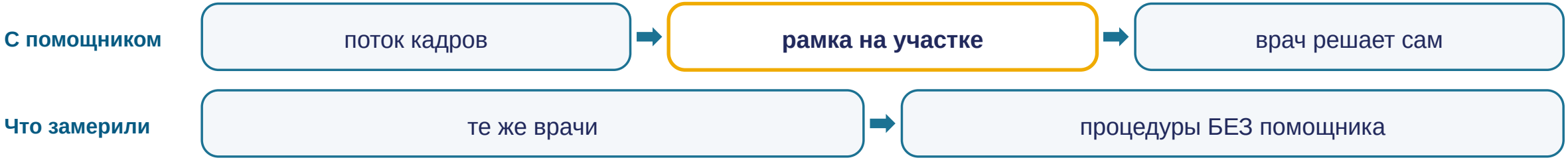
224 из тысячи

145 на 648

ПРИВЕЛО

минус 60 находок на тысячу

19 врачей, стаж 28 лет



Где стоит помощник и где замерили врача без него

Что делали. В четырёх центрах Польши эндоскопистам дали помощника, обводящего находку рамкой. Через три месяца сравнили процедуры тех же врачей **без** него.

Дало: находят больше, пока включён. **Потребовало:** умения искать самому. **В сумме:** исполнитель тот же — место, объём и рука прежние, — но стал хуже.

Имени своей системы публикация не называет.

Budzyń и соавт., Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025 · *Bastani и соавт., PNAS 2025*

Пример 2: отечественный помощник ArtInCol на той же процедуре

БЕЗ ПОМОЩНИКА

413 процедуры с находкой из тысячи

547 пациентов

С ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПОМОЩНИКОМ

472 процедуры из тысячи

581 пациент

ЧЕГО У ИСПЫТАНИЯ НЕТ

замера после снятия помощника

Устройство	видеопоток со стандартного прибора →	компьютер у стойки →	**рамка на мониторе**
Обучено на	архиве НМИЦ колопроктологии →	разметке эндоскопистов того же центра	

Отечественная система в том же месте потока

Что делали. В четырёх учреждениях Москвы и Уфы 1 128 пациентов разделили жребием: колоноскопия как обычно и с отечественным помощником, обводящим участок рамкой на мониторе.

Сильнее польского: там смотрели назад по архиву, здесь распределили жребием заранее.

Цена рамки: 1,23 ложного срабатывания на исследование — столько раз врач смотрит на пустое место.

Ачкасов С.И., Шелыгин Ю.А. и соавт. Эффективность системы искусственного интеллекта ArtInCol в диагностике новообразований при колоноскопии : результаты многоцентрового рандомизированного исследования. Колопроктология, 2025; 24(3):12–21

Свод стадии: что получается, что нет и что из этого про вас

У ВРАЧЕЙ

284 → 224 находки на тысячу процедур

наблюдательно, однажды

В УЧЁБЕ, ЖРЕБИЕМ

экзамен без модели на 17 % ниже контроля

около 1 000 школьников

ПРОТИВОВЕС

у 69 новичков через неделю расход не подтвердился

Получается: находят больше, пока включён — измерено жребием и повторено.

Не получается: поддерживать навык (измерено обратное) · сказать врачу о пропуске внутри процедуры · измерить доверие за месяцы работы.

Появился шаг: разбирать расхождение врача и модели. Перепроверка всего потока ушла: защита сменилась, а не сократилась.

Врача без помощника не измеряет ни одна процедура ни в одной стране.

Про вас: неограниченный помощник создаёт видимость обучения — в работе результат выше, на проверке ниже. Лечится устройством доступа, не объёмом практики.

Budzyń и соавт., Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025

Два режима подсветки: где человек остаётся и где его снимают

ГДЕ РАСХОДУЕТСЯ НАВЫК

там, где человек формально остался

подсветка на видео

Подсветка на видео	врач ведёт процедуру	**рамка на участке**	смотрит и решает сам
Второй читатель снимка	снимок готов	**заключение модели**	второго человека нет

Один класс инструмента, два режима — и что остаётся человеку

Один класс инструмента в двух режимах, и разница не в точности.

Подсветка на видео. Рамка появляется, пока врач ведёт процедуру: он смотрит сам, с рамкой или без.

Второй читатель снимка. Модель встаёт на место второго человека — и человека с этого места снимают совсем.

Навык расходуется в первом случае — там, где человек формально остался и работу продолжает делать он.